

表3 呼吸リハビリテーションの評価

1. 必須の評価
・フィジカルアセスメント ・スパイロメトリー* ・胸部単純X線写真* ・心電図* ・呼吸困難（安静時，日常生活動作時，歩行時など） ・経皮的酸素飽和度（SpO ₂ ） ・ADL ・歩数（身体活動量） ・フィールド歩行試験（6分間歩行試験，シャトル・ウォーキング試験）** ・握力 ・栄養評価（BMI，%IBW，%LBWなど）
2. 行うことが望ましい評価
・上肢筋力，下肢筋力 ・健康関連QOL（包括的，疾患特異的） ・日常生活動作におけるSpO ₂ モニタリング
3. 可能であれば行う評価
・身体活動量（活動量計） ・呼吸筋力 ・栄養評価〔質問票，体成分分析（LBMなど），エネルギー代謝，生化学的検査など〕 ・動脈血ガス分析 ・心理社会的評価 ・心肺運動負荷試験 ・心臓超音波検査

*：外来診療などで実施済みの場合は内容を確認

**：運動負荷が禁忌な病態をあらかじめスクリーニングしておくこと。在宅，訪問リハビリテーションにおける実施を除く。

[植木 純ほか：日呼吸ケアリハ会誌 27：95-114，2018 より許諾を得て転載]

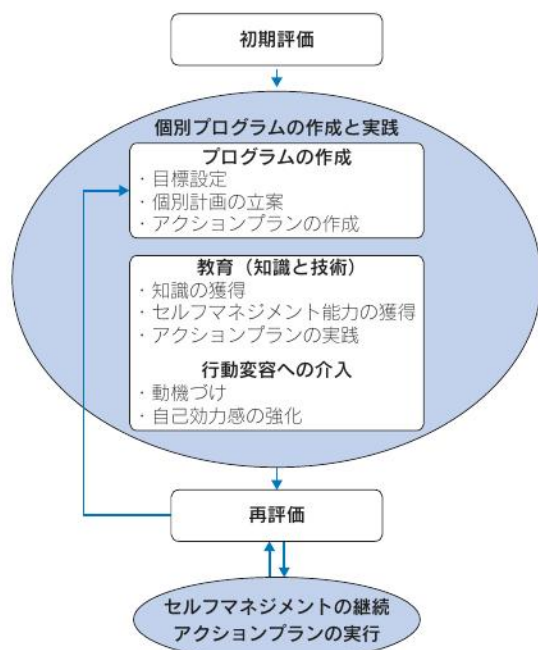


図1 セルフマネジメント教育のプロセス

[日本呼吸ケア・リハビリテーション学会/日本呼吸理学療法学会/日本呼吸器学会：呼吸器疾患患者のセルフマネジメント支援マニュアル，p29，2022 より許諾を得て転載]

運動療法であり，呼吸リハに対する要望が高いことが示されている⁷⁾。

4 身体活動性の向上・維持

身体活動性の低下はCOPDの入院を増加させ，増悪入院後の再入院も増加させる。また，死亡リスクを増大させる強い予後因子である¹⁾。一方で運動耐容能の改善は必ずしも身体活動性の向上にはつながらない。息切れへの不安感の軽減や行動変容への介入（behavioral modification intervention）などを加えて，身体活動性を向上・維持させていく必要がある。

文 献

- 1) 植木純ほか：日呼吸ケアリハ会誌 27：95，2018
- 2) 日本呼吸ケアリハビリテーション学会呼吸リハビリテーション委員会ワーキンググループほか（編）：呼吸リハビリテーションマニュアル—運動療法—，第2版，照林社，2012
- 3) 特発性肺線維症の治療ガイドライン」作成委員会：特発性肺線維症の治療ガイドライン2023，改訂第2版，p29-30，南江堂，2023
- 4) Kataoka K, et al：Thorax 78：784，2023
- 5) Langer D：Respiration 89：353，2015
- 6) 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会/日本呼吸理学療法学会/日本呼吸器学会：呼吸器疾患患者のセルフマネジメント支援マニュアル，p1-244，2022
- 7) 呼吸不全に関する呼吸ケア白書作成ワーキンググループ：2024呼吸不全に関する在宅ケア白書，第1版，p1-169，メディカルレビュー社，2024